

CONSENTIMIENTO INFORMADO

SIMPATECTOMÍA TORÁCICA VIDEOTORACOSCÓPICA BILATERAL

Tratamiento quirúrgico de la hiperhidrosis primaria (palmar / axilar / craneofacial) y del rubor facial

Apellido y Nombre			
DNI		Fecha de nacimiento	___/___/___
Edad		Sexo	
Domicilio			
Obra Social		N° de afiliado	
Institución / Sanatorio	Clínica Calchaquí	Fecha del acto	___/___/___
Médico interviniente	Dr. Pablo Maynard — Cirujano Torácico UBA — M.N. 121828 / M.P. 232938		

Procedimiento propuesto (marcar lo que corresponda):

Territorio a tratar: ☐ Palmar ☐ Axilar ☐ Craneofacial ☐ Rubor facial

Nivel planificado*: ☐ R3 ☐ R4 ☐ R4 + R5 ☐ Otro: _____

Técnica: ☐ Sección / cauterización (simpaticotomía) ☐ Clips

Abordaje: ☐ Uniportal (UVATS) ☐ Biportal

*El nivel se describe según la costilla sobre la cual se interrumpe la cadena simpática (R3 = 3ª costilla), de acuerdo con el consenso de la Society of Thoracic Surgeons.

1. DIAGNÓSTICO

Hiperhidrosis primaria focal — territorio/s: _____ — HDSS preoperatorio: palmar ___/4 · axilar ___/4 · plantar ___/4 · craneofacial ___/4

Tratamientos previos: antitranspirantes / iontoforesis / oxibutinina u otro anticolinérgico / toxina botulínica / otros: _____

Antes de indicar la cirugía se evaluaron y descartaron, en lo razonablemente posible, causas secundarias de sudoración excesiva (medicamentos, enfermedades endocrinas, infecciosas, neurológicas u oncológicas).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La sudoración de manos, axilas y cara está controlada por la cadena simpática, un cordón nervioso que corre a ambos lados de la columna, dentro del tórax. La simpatectomía consiste en interrumpir esa cadena a la altura indicada para disminuir la señal nerviosa que llega a las glándulas sudoríparas de la zona a tratar.

Bajo anestesia general, y por lo general con el paciente semisentado, se realiza a cada lado del tórax una incisión pequeña (uniportal) o dos (biportal), habitualmente en la región axilar. Con una cámara se identifica la cadena simpática y se la interrumpe sobre la costilla planificada, mediante sección/cauterización o colocación de clips, extendiendo la interrupción unos centímetros sobre la costilla para abarcar fibras nerviosas accesorias. El procedimiento se realiza en ambos lados en el mismo acto quirúrgico. Al finalizar se reexpande el pulmón; en algunos casos se deja un drenaje fino por pocas horas. En la mayoría de los pacientes el alta es en el día o a las 24 horas.

3. OBJETIVO Y BENEFICIOS ESPERADOS

El objetivo es eliminar o reducir en forma marcada la sudoración de la zona tratada y mejorar la calidad de vida. La hiperhidrosis primaria no pone en riesgo la vida ni daña órganos: la indicación de esta cirugía es exclusivamente por su impacto en la calidad de vida.

Resultados publicados en la bibliografía: **manos: mejoría en más del 95% de los casos; cara: alrededor del 90%; axilas: alrededor del 70–80%**, con resultado menos predecible que en las manos. La sudoración de los pies puede mejorar en una parte de los pacientes, pero **esa mejoría no se garantiza**. En el rubor facial los resultados son menos consistentes.

Con el nivel R4 las manos suelen quedar secas pero con algo de humedad, con menor riesgo de sudoración compensatoria; con el nivel R3 las manos quedan más secas, con algo más de riesgo de sudoración compensatoria. El nivel fue elegido en conjunto con el paciente según sus prioridades.

4. RIESGOS Y COMPLICACIONES POSIBLES

4.1 Sudoración compensatoria (efecto adverso principal)

- **Es el efecto adverso más frecuente e importante de esta cirugía y el principal motivo de insatisfacción.** Consiste en un aumento de la sudoración en zonas no tratadas —espalda, abdomen, pecho, glúteos, muslos o detrás de las rodillas—, sobre todo con el calor y el ejercicio.
- **La mayoría de los pacientes presenta algún grado de sudoración compensatoria.** En la mayor parte de los casos es leve y tolerable, pero **entre 1 de cada 20 y 1 de cada 5 pacientes (aproximadamente 5% a 25%) la vive como severa**, y en una minoría puede resultar más molesta que la sudoración original.
- Suele aparecer en las primeras semanas o meses. En muchos pacientes se estabiliza o mejora con el tiempo, pero en otros puede aumentar con los años.
- **No es posible predecir con certeza quién la va a presentar ni con qué intensidad.** Aumentan el riesgo: mayor edad (en especial a partir de los 25 años), sobrepeso, tabaquismo, el tratamiento de cara, rubor o axila aislada, y una interrupción más alta o de más niveles de la cadena.
- **No existe un tratamiento que la elimine por completo.** Las opciones disponibles (medidas generales, antitranspirantes, medicación oral anticolinérgica, toxina botulínica en zonas pequeñas, retiro de clips o reconstrucción de la cadena) tienen resultados parciales e inconsistentes.
- **La simpatectomía debe considerarse irreversible.** Cuando se utilizan clips, su retiro no garantiza revertir la sudoración compensatoria ni sus efectos; de considerarse, debería hacerse en forma temprana (primeras semanas) y puede acompañarse del regreso de la sudoración original.

4.2 Otros riesgos específicos

- Neumotórax residual (aire remanente en el tórax): frecuente en la radiografía y casi siempre pequeño; pocas veces requiere colocar un drenaje.
- Sangrado por lesión de vasos intercostales o venas próximas a la cadena: infrecuente; excepcionalmente puede requerir drenaje, transfusión o conversión a cirugía abierta.
- Síndrome de Horner (caída del párpado y pupila más pequeña del mismo lado): menos del 1%; puede ser permanente.
- Sudoración gustatoria (sudor en cara o tronco al comer): se presenta en una minoría de pacientes.
- Sequedad excesiva de las manos, que puede requerir cremas hidratantes.
- Disminución de la frecuencia cardíaca o menor aumento de la misma con el esfuerzo, más relevante en deportistas.
- Resultado insuficiente o recurrencia de la sudoración, con eventual necesidad de tratamiento médico o de una nueva cirugía.
- Dolor torácico, neuralgia intercostal u hormigueo en la zona de las incisiones, en general transitorios.
- Imposibilidad de completar el procedimiento de un lado o necesidad de convertir a cirugía abierta por adherencias pleurales u otros hallazgos (poco frecuente).
- Otros descriptos y poco frecuentes: congestión nasal (rinitis), sensación de sudoración sin sudor («sudoración fantasma»).

4.3 Riesgos generales de la anestesia y de la cirugía

- Reacciones a la anestesia general, complicaciones cardiovasculares o respiratorias.

- Infección de las heridas quirúrgicas.
- Neumonía y/o atelectasia postoperatoria.
- Trombosis venosa profunda y/o tromboembolismo pulmonar (infrecuentes).
- Necesidad de reoperación.
- Muerte, como riesgo excepcional pero posible de todo procedimiento bajo anestesia general.

5. ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS

Existen tratamientos no quirúrgicos que se indican en forma escalonada según la zona y la severidad: medidas generales; antitranspirantes con sales de aluminio; iontoforesis (manos y pies); medicación oral anticolinérgica como oxibutinina o glicopirrolato (efecto adverso más común: boca seca); inyección de toxina botulínica (efecto de varios meses, requiere repetirse); anticolinérgicos tópicos y dispositivos de termólisis axilar (microondas, parche de termólisis alcalina), estos últimos de disponibilidad limitada en nuestro país. Ninguno es definitivo, pero no generan sudoración compensatoria.

Respecto de estas alternativas, declaro que (marcar):

- ☐ Las he probado sin resultado satisfactorio o no las toleré.
- ☐ Fui informado/a de ellas y de la conveniencia de probarlas antes de operarme, y decido libremente optar por la cirugía.

6. CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

La hiperhidrosis primaria no pone en riesgo la vida ni daña órganos. De no operarse, persistirá la sudoración excesiva y su impacto en la vida diaria, con la posibilidad de continuar o iniciar tratamiento médico en cualquier momento. No realizar la cirugía no agrava la enfermedad ni impide optar por ella más adelante.

7. DECLARACIÓN DEL PACIENTE

Declaro que el Dr. Pablo Maynard y su equipo me han explicado, en lenguaje claro y comprensible, mi diagnóstico, el procedimiento propuesto, sus beneficios esperados, los riesgos y complicaciones posibles —generales y específicos—, las alternativas terapéuticas disponibles y las consecuencias previsibles de no realizar el procedimiento. He tenido la oportunidad de formular todas las preguntas que consideré necesarias y las mismas fueron respondidas de manera satisfactoria. Comprendo que la Medicina no es una ciencia exacta y que no se me ha garantizado un resultado determinado. En consecuencia, presto mi consentimiento libre, voluntario e informado para la realización del procedimiento descrito en el presente documento, incluyendo los procedimientos anestésicos necesarios para su realización.

Declaro además haber comprendido especialmente que: (a) la sudoración compensatoria es frecuente, puede ser severa, no puede predecirse y no tiene un tratamiento que la elimine; (b) la cirugía debe considerarse irreversible; (c) no se me garantiza la mejoría de la sudoración de pies ni un resultado completo en axilas o cara; (d) se trata de una cirugía programada para mejorar mi calidad de vida, que puedo decidir no realizar.

Iniciales del paciente: _____

8. AUTORIZACIONES ADICIONALES

- ☐ Autorizo la ampliación o modificación del procedimiento planificado si, durante el acto operatorio, surgieran hallazgos imprevistos que a criterio del equipo actuante hagan necesario o conveniente dicho cambio para preservar mi salud o mi vida.
- ☐ Autorizo la administración de hemoderivados (transfusión) en caso de ser necesario.
- ☐ Autorizo el registro de fotografías de las zonas de sudoración y de escalas de severidad y calidad de vida antes y después de la cirugía, para documentar el resultado, y el uso anonimizado de mis datos clínicos con fines de investigación y publicación científica, resguardando mi identidad (Ley 25.326).
- ☐ Autorizo la toma de fotografías/videos del procedimiento con fines académicos y/o de docencia, resguardando mi identidad (Art. 8º, Ley 26.529). En caso de no autorizar, tildar la opción correspondiente:
- ☐ No autorizo la toma de fotografías/videos con fines académicos.

9. REVOCABILIDAD DEL CONSENTIMIENTO

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento previo a la realización del procedimiento, sin necesidad de expresar causa y sin que ello genere consecuencia negativa alguna sobre mi atención médica posterior (Art. 10, Ley 26.529).

En pacientes menores de 18 años, el consentimiento se otorga conforme al art. 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, con la firma del paciente y de su/s representante/s legal/es.

10. FIRMAS

Firma: _____ PACIENTE — Nombre: _____ DNI: _____	
Firma: _____ REPRESENTANTE LEGAL (si corresponde) — Nombre: _____ DNI: _____ Vínculo: _____	
Firma y sello: _____ MÉDICO INTERVINIENTE Dr. Pablo Maynard — M.N. 121828 / M.P. 232938	Firma: _____ TESTIGO (opcional) — Nombre: _____ DNI: _____